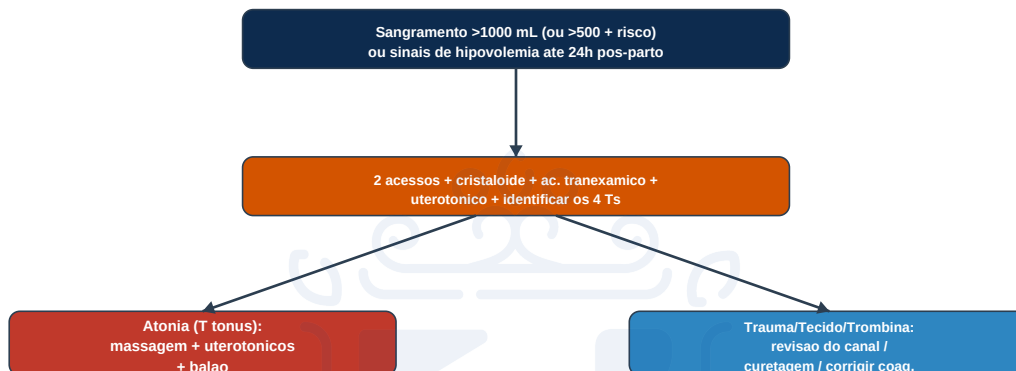


HEMORRAGIA PÓS-PARTO — OS 4 Ts

FLUXOGRAMA — RECONHECER E AGIR

HPP — RESSUSCITAR + IDENTIFICAR A CAUSA (4 Ts)



DEFINIÇÃO E DIAGNÓSTICO

O QUE É

- Perda > 1.000 mL independentemente da via de parto
- OU parto vaginal com fatores de risco e perda > 500 mL
- OU sinais/sintomas de hipovolemia em até 24h após o parto (HPP primária)
- Principal causa de morte materna evitável — reconhecimento e ação precoces salvam vidas

CAUSAS — OS 4 Ts

T	Causa	Frequência / pista
TÔNUS	Atonia uterina	CAUSA MAIS COMUM (~70%); útero amolecido
TRAUMA	Laceração de trajeto, rotura uterina, inversão	Útero contraído mas sangra; revisar canal
TECIDO	Retenção placentária / restos / acretismo	Placenta incompleta; útero não contrai bem
TROMBINA	Coagulopatia (CIVD, anticoagulante)	Sangramento difuso, sem coágulos

FATORES DE RISCO

ANTECIPAR

- Placenta prévia / inserção baixa; acretismo placentário; DPP
- Pré-eclâmpsia com sinais de gravidade
- Hematócrito < 30%; plaquetas < 100.000; coagulopatias; uso de anticoagulante
- Sangramento ativo na admissão
- Sobredistensão uterina (gemelar, polidrâmnio), trabalho de parto prolongado

PREVENÇÃO (manejo ativo do 3o período)

Rx PROFILAXIA NO NASCIMENTO

Ocitocina 10 UI IM imediatamente após o nascimento (opção: misoprostol 600-800 mcg via retal)
Manejo ativo do terceiro período do trabalho de parto
Clampeamento oportuno do cordão (1-3 min)
Tração controlada do cordão umbilical
A profilaxia com uterotônico reduz drasticamente a incidência de HPP

CONDUTA NA HPP INSTALADA

Rx RESSUSCITAR + ESTANCAR

Monitorização; 2 acessos calibrosos; cristaloide e avaliar HEMOTRANSFUSÃO (protocolo de transfusão maciça se grave)
Exames: tipagem, hemograma, coagulograma, eletrólitos; graves: + lactato/gasometria
ÁCIDO TRANEXÂMICO 1 g EV em 100 mL SF em 10 min (precoce, < 3h)
Revisão do canal de parto (trauma) e avaliação de restos (tecido)
Atonia: massagem uterina + compressão (manobra de Hamilton, bimanual) + uterotônicos
Uterotônicos: ocitocina, ergometrina (evitar se HAS), misoprostol; carbetocina conforme disponibilidade

ATONIA REFRACTÁRIA — MEDIDAS MECÂNICAS/CIRÚRGICAS

ESCALONAR

- Balão de tamponamento intrauterino: falha das terapias para atonia; medida TEMPORÁRIA e para transporte ao centro de referência
- Contraindicações: gestação, infecção genital interna, anomalia que distorce a cavidade, rotura uterina, sangramento arterial que exige cirurgia/embolização
- Outras: dispositivo de controle hemorrágico por vácuo, traje antichoque (TAN) para compressão externa
- Cirúrgico/intervencionista: suturas compressivas (B-Lynch), ligadura/embolização de artérias uterinas, histerectomia (último recurso)
- Acionar centro de referência precocemente na HPP grave/refratária

CHECKLIST NO PS

NÃO ESQUECER

- ☐ Reconhecer pelos critérios (>1000 mL; >500 mL com risco; sinais de hipovolemia)
- ☐ Ressuscitar (acessos, cristaloide, transfusão) + ácido tranexâmico precoce
- ☐ Identificar a causa pelos 4 Ts (tônus, trauma, tecido, trombina)
- ☐ Atonia: massagem + uterotônicos + balão se refratário
- ☐ Acionar transporte ao centro de referência (com balão/TAN) se refratário

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Puérpera com HPP (perda estimada ____ mL; via de parto ____); causa provável (4 Ts): ____.
- Estabilidade: ____; Hb ____; coagulograma ____; ácido tranexâmico feito: sim/não.
- Condutas: uterotônicos ____, massagem/manobras, balão de tamponamento/TAN.
- Solicito transferência ao centro de referência (cirurgia/embolização) + reserva de hemocomponentes.

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Puérpera com sangramento volumoso e útero amolecido (não contraído) após parto vaginal. Qual a causa mais provável e a conduta inicial?

- A) Laceração de trajeto — sutura imediata
- B) Atonia uterina — massagem uterina + uterotônicos (ocitocina) ± balão se refratário
- C) Coagulopatia — apenas plasma
- D) Retenção placentária — histerectomia imediata
- E) Inversão uterina — observação

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Quais são os '4 Ts' das causas de hemorragia pós-parto?

- A) Tônus, Trauma, Tecido e Trombina
- B) Trombo, Tumor, Trauma e Toxina
- C) Tireoide, Trombo, Tecido e Tônus
- D) Tempo, Trauma, Tônus e Trombina
- E) Tônus, Tempo, Tumor e Tecido

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual medicação antifibrinolítica deve ser administrada precocemente na HPP?

- A) Ácido tranexâmico 1 g EV
- B) Heparina
- C) Vitamina K
- D) Ácido acetilsalicílico
- E) Protamina

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Qual a medida de PREVENÇÃO da HPP no manejo ativo do 3o período do parto?

- A) Tração vigorosa imediata do cordão sem uterotônico
- B) Ocitocina 10 UI IM logo após o nascimento + tração controlada do cordão
- C) Massagem uterina apenas se sangrar
- D) Clampeamento imediato sem ocitocina
- E) Misoprostol intravenoso

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual o papel do balão de tamponamento intrauterino na HPP por atonia?

- A) Tratamento definitivo e curativo
- B) Medida temporária na falha das terapias, útil também para transporte ao centro de referência
- C) Primeira linha antes dos uterotônicos
- D) Contra-indicado em qualquer atonia
- E) Substitui a reposição volêmica

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Útero amolecido/não contraído com sangramento é atonia uterina (T de Tônus), a causa mais comum de HPP. Conduta: massagem uterina + uterotônicos (ocitocina em 1a linha), escalonando para balão/medidas cirúrgicas se refratário.

QUESTÃO 2 → Resposta: A

Os 4 Ts: Tônus (atonia, ~70%), Trauma (lacerações/rotura/inversão), Tecido (retenção placentária/restos/acretismo) e Trombina (coagulopatia). Orientam a busca sistemática da causa.

QUESTÃO 3 → Resposta: A

O ácido tranexâmico 1 g EV deve ser administrado precocemente (idealmente < 3h) na HPP, reduzindo a mortalidade por sangramento (antifibrinolítico).

QUESTÃO 4 → Resposta: B

O manejo ativo do 3o período inclui ocitocina 10 UI IM logo após o nascimento, clampeamento oportuno (1-3 min) e tração controlada do cordão — reduz a incidência de HPP.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

O balão de tamponamento intrauterino é medida temporária na atonia refratária às terapias iniciais, também usada para estabilizar e transportar a paciente ao centro de referência. Não é tratamento definitivo.

SM24
Suporte ao Plantão Médico